Casa di Cura San Germano al Colle
Ospedale privato accreditato - polispecialistico
U.O. Ortopedia e Traumatologia
Responsabile: Dott. Matteo Zordan

Via Pasubio 212
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 389100
Fax 0445 389120
ortopedia@sangermano.example.it

Egr. Dott. Lorenzo Cazzola, MMG - Malo
Spett. Centro di Riabilitazione Monte Summano
Alla c.a. Dott.ssa Chiara Busato - fax 0444 712093

RELAZIONE CLINICA DI DIMISSIONE E TRASFERIMENTO

Chirurgia ortopedica senza trasfusione di sangue (percorso bloodless)

DATI DEL PAZIENTE

Paziente:	**Gemma Dal Bosco**
Nata a / il:	**Vicenza, 19/01/1944**
Residenza:	**Contrà San Bernardino 6, 36034 Malo**
Stato civile:	**vedova**
Assicurazione:	**Previdenza Veneta Assicurazioni, polizza n. PVA-77-3381042**

Ricovero:	24/02/2025 (da PS)
Dimissione:	07/03/2025
Nosologico:	2025/001874
Esenzione:	C03
Assistente familiare:	Oksana Kovalenko, tel. +39 380 225 9714

C.F. D L B G M M 4 4 A 5 9 L 8 4 0 Z

Tessera sanitaria 8 0 3 8 0 0 5 0 7 1 6 8 4 6 2 0 1 0 1 9

VOLONTÀ DELLA PAZIENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTI CON SANGUE

La paziente, Testimone di Geova, capace di intendere e di volere all'ingresso, ha confermato per iscritto il rifiuto di trasfusioni di sangue intero, emazie, plasma e piastrine, anche in pericolo di vita, come già espresso nelle Disposizioni Anticipate di Trattamento depositate il 12/05/2021 presso il Comune di Malo. Fiduciario nominato nelle DAT: il figlio, sig. Alberto Dal Bosco. Dichiarazione raccolta dal Dott. Matteo Zordan alla presenza dell'inf. Sole Marchetto il 24.02.25.

Trattamenti accettati dalla paziente

- ☐ Emazie / sangue intero
- ☐ Plasma / piastrine
- ☒ Albumina e frazioni
- ☒ Recupero intraoperatorio
- ☒ Eritropoietina
- ☒ Acido tranexamico

ANAMNESI E MOTIVO DEL RICOVERO

Paziente di 81 anni, vive a domicilio con l'assistente familiare sig.ra Kovalenko, autonoma nella deambulazione con bastone. Comorbilità: fibrillazione atriale permanente in terapia con edoxaban 30 mg, malattia renale cronica stadio 3b, diabete mellito tipo 2, decadimento cognitivo lieve (MMSE di Folstein 23/30 nel 2024). Il 23 febbraio 2025, in serata, caduta accidentale in cucina con impossibilità alla stazione eretta; soccorsa dalla sig.ra Oksana e condotta in PS, dove è stata posta diagnosi di **frattura sottocapitata del collo femorale sinistro, tipo Garden III**.

INTERVENTO CHIRURGICO

Data / tipo	Équipe	Note intraoperatorie
26/02/2025 endoprotesi biarticolare cementata d'anca sinistra	1° op. Dott. Matteo Zordan 2° op. Dott.ssa Ilaria Sartori De Marchi Anest. Dott. Pierluigi D'Ambrosio Strum. Davide Peruzzo	anestesia spinale; acido tranexamico 1 g e.v. pre-incisione e a fine intervento; recupero intraoperatorio in circuito chiuso continuo, reinfusi 210 mL; perdite stimate 450 mL

La strategia di risparmio ematico era stata impostata con l'ematologo consulente, Dott. Thomas Oberhofer: sospensione di edoxaban all'ingresso, ferro carbossimaltosio 1000 mg e.v. il 24/02/2025, epoetina alfa 40.000 UI s.c. in prima e in quarta giornata, riduzione al minimo dei prelievi (provette pediatriche).

ANDAMENTO DELL'EMOGLOBINA

Data	Hb (g/dL)	Ht (%)	Commento
24/02/2025	11,2	34,1	ingresso

Data	Hb (g/dL)	Ht (%)	Commento
27/02/2025	8,3	25,6	nadir in I giornata post-operatoria; paziente asintomatica, emodinamicamente stabile; rinnovato colloquio con la paziente e con il figlio: confermato il rifiuto trasfusionale
03/03/2025	9,1	28,2	reticolociti in aumento
06/03/2025	9,8	30,0	alla dimissione

DECORSO POST-OPERATORIO

In seconda giornata comparsa di delirium ipoattivo, valutato dalla geriatra Dott.ssa Nadia Bortoli e trattato con misure non farmacologiche (riorientamento, presenza della sig.ra O. Kovalenko e del figlio durante il giorno) e quetiapina 25 mg la sera per 4 giorni, con risoluzione. Ripresa di edoxaban 30 mg dal 01/03/2025 dopo valutazione del rischio emorragico. Mobilizzazione con deambulatore dalla terza giornata con la fisioterapista Viola Tessari; carico completo concesso. Ferita chirurgica in ordine; Harris Hip Score alla dimissione 52. La sig.ra Dal Bosco ha ricevuto in reparto la visita di un ministro di culto della propria congregazione, su sua richiesta.

DIAGNOSI DI DIMISSIONE

Frattura sottocapitata del collo del femore sinistro (Garden III) trattata con endoprotesi biarticolare cementata in regime bloodless. Anemia post-operatoria gestita senza emotrasfusione. Delirium post-operatorio risolto.

TERAPIA ALLA DIMISSIONE

Farmaco	Schema	Note
Edoxaban 30 mg	1 cp ore 18	funzione renale da ricontrollare a 2 settimane
Metformina 500 mg	1 cp a pranzo e a cena	invariata
Paracetamolo 1 g	1 cp fino a 3 volte/die	al bisogno per dolore
Colecalciferolo 25.000 UI	1 flacone ogni 15 giorni	prevenzione secondaria fratture; valutare terapia anti-osteoporotica
Ferro solfato 80 mg	1 cp/die	per 2 mesi; controllo emocromo e ferritina a 30 giorni

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Prestazione erogata in convenzione SSN con integrazione alberghiera (camera singola) a carico della polizza PVA-77-3381042; pratica di rimborso n. SX-25-004417 aperta con Previdenza Veneta Assicurazioni.

Il deposito cauzionale versato all'ingresso verrà restituito con bonifico sul conto intestato al figlio Alberto Dal Bosco, IBAN IT62K6760137158252853852347, come da modulo firmato il 07/03/2025.

Il Medico Responsabile dell'U.O.

Dott. Matteo Zordan

CASA DI CURA SAN GERMANO
Ortopedia - Dott. M. ZORDAN
OMCeO VI n. 4418

Schio, 07/03/2025

RICEVUTO
CENTRO RIAB. MONTE SUMMANO
il 07/03/2025 ore 16:05
firma R. Pellizzari

ALLEGATO - SCHEDA INFERMIERISTICA DI TRASFERIMENTO

Indice di Braden:	14 (rischio moderato)	Scala di Conley:	6 (rischio cadute)	Barthel alla dimissione:	45/100
Catetere vescicale:	rimosso il 01/03/2025	Ultima evacuazione:	06/03/2025	Allergie:	cerotti in tessuto acrilico

Ambito	Situazione alla dimissione	Indicazioni per il centro ricevente
Ferita chirurgica	medicazione in ordine, agrafes in sede	rimozione agrafes in 12/03/2025 (XIV giornata)
Mobilità	deambulatore, carico completo, trasferimenti con assistenza minima	evitare adduzione e rotazione interna dell'arto operato; cuscino abduttore a letto
Alimentazione	dieta per diabetici, disfagia assente	glicemia capillare prima dei pasti principali
Aspetti relazionali	paziente orientata; preferisce la presenza dell'assistente familiare Oksana Kovalenko nelle ore serali	orari di visita concordati con il figlio Alberto Dal Bosco
Volontà espresse	rifiuto di emotrasfusione (vedi pag. 1)	conservare la tessera DAT della paziente insieme alla documentazione clinica

La Coordinatrice infermieristica

Compilata il 07.03.25

Sole Marchetto

(1) Il rifiuto di emocomponenti è stato rinnovato dalla paziente, capace, in data 27/02/2025 alla presenza del figlio A. Dal Bosco e dell'anestesista Dott. P. D'Ambrosio; copia della dichiarazione è allegata in cartella.
(2) Si raccomanda al centro di riabilitazione di mantenere il percorso bloodless e di contattare, per ogni decisione, il fiduciario indicato.
(3) Valori di Hb inferiori a 7 g/dL o segni di instabilità emodinamica vanno segnalati al reparto inviante, tel. 0445 389142 (medico di guardia).